جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سهير فتحي ناشد عوض
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه **العنوان :** --
رقم البطاقة : 26412161400445 **رقم التليفون :** 01228812220 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 16-12-1964 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سهير فتحي ناشد عوض
National ID: 26412161400445

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Name:	Souhair Fathi // Awad
MR. :	7385

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتة

تاريخ وساعة الدخول : mm/dd/yyyy --:--

تاريخ وساعة الخروج : mm/dd/yyyy --:--

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

breast cancer

for

bone scan

تحريرا في ,

الوقت : --:--

التاريخ : mm/dd/yyyy

الطبيب المعالج : .....

يعتمد ,

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مشهير
فتحى ناشد عوض
١٢٠ش محمود رضا
شبرا الخيمه ثان - القليوبية

٢٦٤ ١٢ ١٦ ١٤ ٠٠٤ ٤٥

IQ1407547

National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

٢٠٢٠/١١ ٢٢٤١٢١٦١٤٠٠٤٤٥

انثى مسيحية أرملة

١١ ـ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١١/٠٧



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / سهير فتحى ناشد	Request No.	: 133299
Patient No.	: 26412161400445	Request Date	: 18/12/2021
Path No.	: 3141/21	Verification Date	: 26/12/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 57 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast mass

Nature of the speciment:
Tru-Cut biopsy

Gross Examination:
Multiple greyish white tissue cores, up to 2cm. Totally submitted.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma grade II, with focal insitu components
- Angioinvasion: No
- Lymph node involvement: N/A
- Resection Margins: N/A
- Histologic response to therapy: N/A

Diagnosis:
Right breast mass; Tru-Cut biopsy:
Invasive duct carcinoma grade II, with focal insitu components.
For IHC (ER, PR, Her-2, Ki67)

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (957) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 957- Nile Corniche - Misr El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

عينة الورم ج

Patient Name	: الأستاذه / سهير فتحى ناشد	Request No.	: 133299
Patient No.	: 26412161400445	Request Date	: 18/12/2021
Path No.	: 3141/21	Verification Date	: 03/01/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 57 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Right breast mass

Nature of the speciment:
Tru-Cut biopsy

Gross Examination:
- Multiple greyish white tissue cores, up to 2cm. Totally submitted.
- Sections prepared from paraffin blocks for immune-staining using Bench-Mark ULTRA system for ER, PR, Her-2 and Ki67
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her-2 clone (4B5), & Anti-K-67 (30-9)

Microscopic examination:
• Histological type: Invasive duct carcinoma grade II, with focal insitu components
• Angioinvasion: No
• Lymph node involvement: N/A
• Resection Margins: N/A
• Histologic response to therapy: N/A
Biomarkers:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Weak nuclear reaction in 10% of tumor cells (Allred score 3/8)
Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
Ki 67: 20 % nuclear reaction

Diagnosis:
Right breast mass; Tru-Cut biopsy:
Invasive duct carcinoma grade II, with focal insitu component.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (937) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 937- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / سهير فتحى ناشد	Request No.	133299
Patient No.	26412161400445	Request Date	18/12/2021
Path No.	3141/21	Verification Date	03/01/2022
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	57 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (8/8).
- PR: Positive (3/8).
- HER-2: Positive (score 3+).
- Ki67: positive in 20% of tumor cells.

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Abdulrahman Ibrahim
Dr. Menna Atef
Dr. Walaa Ghonaim

Verified by :

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (937) - كورنيش النيل - ميت عقبة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 937- Nile Corniche - Mit El Qadous- Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / سهير فتحى ناشد		
Patient No.	: 26412161400445	Request No.	: 13006249
Path No.	:	Request Date	: 28/05/2022
Sex	: Female	Verification Date	: 04/06/2022
Age	: 57 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Rt breast cancer, Post NACT.

Nature of the specimen: Rt WLE + SLNB
Gross Examination:
- Procedure: WLE measured 18x8x5cm, skin ellipse measured 12x5cm.
- Localization: Rt
- Tumor extent
  - o Number: A firm greyish white area
  - o Size: 7x5x3cm
  - o Skin involvement: Grossly unremarkable
- Distance from margins: Just below deep margin, (1 cm upper, lateral and medial margins - 2.5cm from inferior margin)
- Lymph nodes number and size: 2 nodules up to 2x1cm, showing extensive fatty infiltration.
- Additional pathologic findings: Received in a separate container = A fibrofatty tissue piece measured 2.5x2cm, enclosing 2 nodules, up to 1cm.
- Frozen section: - Free margins. - Free (0/2) LNs

Microscopic examination:
- Complete histologic response in a previously known carcinoma.
- Lymph node involvement: - SLNB= Free (0/2).
- Separate nodule= Free (0/2)
- Total nodal status= Free (0/4) LNs
- Resection Margins:
  - o Free
- Histologic response to therapy: Complete Pathological response
- Additional pathologic findings: Florid epitheliosis

Diagnosis:

Verified by :
dr.menna atef

Room No. (4) - First Floor Building No. 957 Nile Corniche - Misr El Qadima Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / سهير فتحى ناشد	Request No.	: 13006249
Patient No.	: 26412161400445	Request Date	: 28/05/2022
Path No.	:	Verification Date	: 04/06/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 57 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Rt breast cancer, Rt WLE + SLNB:
- Complete histologic response in a previously known case with carcinoma.
- Lymph node involvement:
- SLNB= Free (0/2).
- Separate nodule= Free (0/2)
- Total nodal status= Free (0/4) LNs
o Free Resection Margins
- Complete Pathological response
- Stage: ypT0, ypN0

Prof. Lubna Omar
Dr. Menna Atef

Verified by :
dr.menna atef

غرفة رقم (4) - الدور الأول - عمارة رقم (397) - كورنيش النيل - منشية القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 397- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name Soheir Fathy Nashed

Date : 2-1-2022

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

** referred case of breast cancer.

1. *Chest:*

- Right breast ill-defined parenchymal enhancement along with diffuse skin thickening and pathological right axillary level I lymph nodes reaching 3.5 x 1.5 cm.
- Multiple bilateral scattered partially calcified pleural plaques.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. *Abdomen and pelvis:*

- The liver is enlarged with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- Few dense sclerotic osseous lesions are seen at D6 and right iliac bone, likely bone islands.
- No destructive lytic osseous lesions.

OPINION:

- Right breast ill-defined parenchymal enhancement along with diffuse skin thickening and pathological right axillary level I lymph nodes.
- No pulmonary or hepatic metastatic deposits.
- Multiple bilateral scattered partially calcified pleural plaques.

Dr. Peter Nashaat, MSc

Dr. Dr. Ola Magdy, MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER
NUCLEAR MEDICINE UNIT

معهد ناصر
مركز الأورام
وحدة الطب النووي

Patient Name: Soheer Fathy Nashed **Date: 10/2/2022**

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorsal and lumbar vertebrae.
- Warm uptake at lower sternal body for follow up.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is freee from serious bone lesions.
- Both kidneys are seen .

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan is advised.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Sherien Mahdy,MD *Huda FAthy , M.D*

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient name: Soheir Fathy Nashed

Date: 16/12/2021

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast palpable lump 1 week ago

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right focal asymmetry with suspicious pleomorphic micro calcifications at the UOQ, rather central
- Another smaller group of calcifications seen at the UIQ rather central posterior third.
- Enlarged right axillary lymph node with focal increased cortical thickness is seen.
- A small circumscribe lesion of fat containing mass seen at the left UOQ middle third, measured 1.7x2.5cm, likely lipoma, confirmed by US.
- Complementary ultrasound revealed area of altered infiltrated palpable parenchyma mounting to mass formation being heterogeneous hypoechoic seen at the right outer quadrant extending from 7-11 o'clock, a mass within is seen, measuring about 20x17 mm, consistent with the mammographic finding.
- Anterior prominent ducts reaching the nipple, can be appreciated
- Few scattered nodules area seen, larges is seen at the left breast, 3o'clock measured 6x11mm
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Ipsilateral right axillary pathologically enlarged lymph node is seen with focal increased cortical thickness 8.8 mm.
- Right pathological level I and II LNs.
- Nonspecific left axillary LN.

Opinion:

- Right breast OQ suspicious area of altered parenchyma mounting to mass formation (BIRADS 4c) for histopathological correlation
- Pathological ipsilateral right axillary and level I, II LN
- Probably Benign findings of the left breast (BIRADS 3)

Yours truly

Dr Engy Abdullah Dr Alaa Ragab

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]